

호흡기

기침

콧물/코막힘

객혈

호흡곤란

시험 관련 코멘트



기침의 경우 급성, 아급성, 만성으로 나누어 생각하면 기억하기 쉽습니다. 특히 만성 기침은 다시 흡연 여부에 따라 나눌 수 있습니다. 각각 해당하는 질환을 잘 정리해 두어야 합니다.

급성 기침의 경우 상기도 감염과 폐렴을, 만성 기침의 경우 비흡연자는 천식, 폐결핵, GERD, 오랜 기간의 흡연자는 폐암, COPD를 먼저 떠올리도록 하세요. 소아 기침 케이스일 경우 폐암, COPD는 배제할 수 있습니다.

기침과 동반될 수 있는 **가래**(양, 색, 점도, 피 나오는지 여부), **콧물/코막힘**, **열**을 질문하는 것을 잊으면 안 됩니다. 또한 고혈압을 동반한 환자라면 기침 유발 약물(ACEi 혈압약 복용 여부)이 있는지 확인하는 것을 잊지 않아야 합니다. **흡연력**, **나이**, **악화 요인**은 감별 진단을 하는 중요한 포인트이므로 잘 정리해 두어야 합니다. 또한 교육 시 환자 상황이나 예상되는 질환에 맞게 교육이 필요합니다. 흡연 중인 경우 금연을 권유하고, 천식, COPD 환자는 독감, 폐렴쌍구균 예방접종하는 것이 필요함을 설명하세요. 알레르기 의심 시 환경 관리의 중요성을 설명해 주어야 합니다.

기침은 질문할 것들도 많고, 흉부 신체 검진에서 시간이 좀 걸리기 때문에 시간 분배에 신경 써야 합니다. 만약 **환자가 담배를 피우다가 끊었다면 칭찬해 주고, 기침이 심한 것 같으면 지금 진료에 대답하기엔 힘들지 않은지 한번 확인해 주어 라보를 챙기시길 바랍니다.** 환자가 기침 시 휴지를 건네면 라보 형성에 도움이 됩니다.

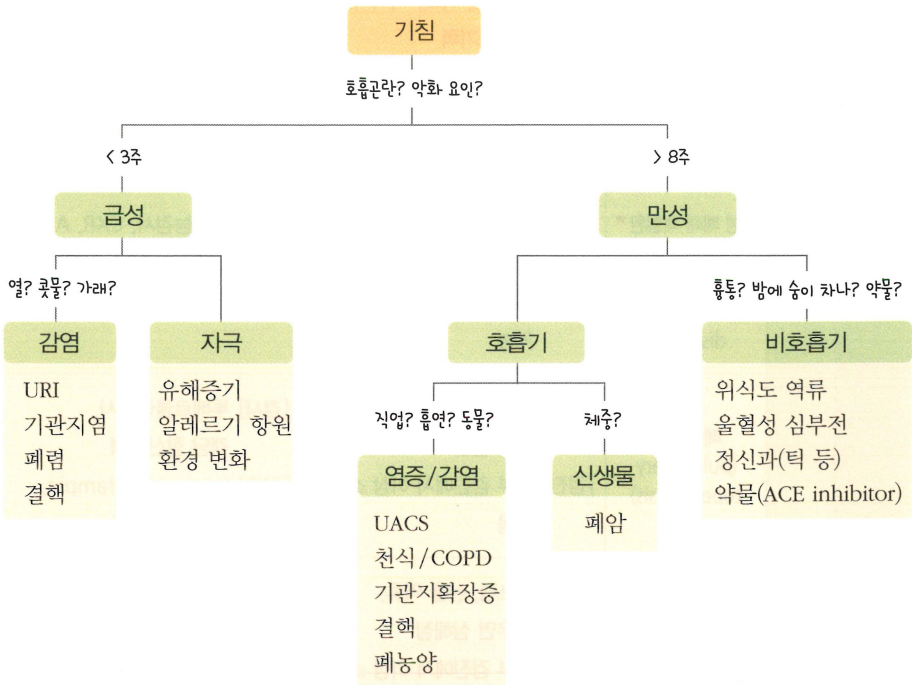
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
급성 < 3주	상 기 도	상기도 감염 (upper respiratory infection)	[병력] 인후통, 기침, 가래, 코막힘 [검진] 구강 시진에서 목이 부어 있음	[검사] 후두경, CBC, CXR [치료] 휴식과 수분 섭취, NSAID, 항생제
	폐	폐렴★ (pneumonia)	[병력] 발열, 콧물, 가래, 호흡곤란, 객혈 [검진] 수포음 청진, 성음진탕 증가, 둔탁음	[검사] CBC, 가래 배양, CXR [치료] Ciprofloxacin / Ceftriaxone + Azithromycin
	지극	유해 증기/ 연기	[병력] 유해 증기/연기 노출력 [검진] 특이 소견 없음	[검사] CXR [치료] 유해물질 회피

아급성		감염 후 기침★ (postinfectious cough)	[병력] 이전에 감기 걸렸던 증상 [검진] 특이 소견 없음	[검사] CBC, 가래 배양, CXR [치료] 휴식과 수분 섭취, Ipratropium
만성 > 8주	상 기 도	후비루 증후군 (postnasal drip syndrome)	[병력] 코가 뒤로 흐르는 느낌, 목이물감, 인후통 [검진] 구강 시진에서 후비루 확인, 부비동염/알레르기 비염	[검사] 부비동 CT, 부비동 X-ray [치료] 원인 질환 치료, 식염수 세척, 진해제
	폐	폐암★ (lung cancer)	[병력] 체중 감소, 흡연자, 고령, 객혈 [검진] 흉부 시촉타청	[검사] chest X-ray, 고해상도 흉부 CT, 기관지내시경, PFT [치료] 수술, 방사선 치료, 항암제
		천식★ (asthma)	[병력] 봄/야간 악화, 쌉쌉거림, 알레르기력 [검진] 흉부 청진에서 쌉쌉거림 가능	[검사] 폐기능검사, chest X-ray, 메타콜린유발검사, 객담검사, 알레르기 피부단자검사 [치료] ICS+SABA, LABA
		만성 폐쇄 폐질환★ (chronic obstructive pulmonary disease)	[병력] 고령, 가래, 흡연자, 호흡곤란 [검진] 흉부 청진에서 쌉쌉거림 가능	[검사] 폐기능검사, CXR, ABGA [치료] SABA, LABA, LAMA, 산소 치료
		폐결핵★ (pulmonary tuberculosis)	[병력] 체중 감소, 발열, 피로, 야간 발한 [검진] 흉부 검진에서 이상 소견 없음	[검사] 투베르쿨린검사, 객담 항산염색 [치료] Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide
	식도	위식도역류병★ (gastroesophageal reflux disease)	[병력] 속쓰림, 신물 역류, 누우면 심해짐 [검진] 흉부 검진에서 이상 소견 없음	[검사] 위내시경, 24시간 식도 내 pH 검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, 수술

	약물	엔지오텐신 전환효소억제제 복용	[병력] 고혈압 약 복용 중(증량, 새로 시작) [검진] 흉부 검진에서 이상 소견 없음	[치료] 약물 변경
	심장	울혈 심부전 (congestive heart disease)	[병력] 호흡곤란, 기저 심질환, 부종, 피로 [검진] 경정맥 확장, 다리 부종 가능	[검사] 심초음파, 심전도 [치료] ACEi, BB, Spironolactone, 이뇨제

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 기침이 시작되었나요? (3~8주)
L	어떤 상황에서 기침이 시작되나요?
D	하루에 몇 번 정도 기침을 하시나요?
Co	증상이 점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? → 치료는?
C	기침을 어떻게 하시나요?/재채기는 아닌가요?/마른기침 or 가래(점도, 색깔, 양) or 피 동반?
A	*코부터 시작해서 순서대로 물어보면 됩니다. 코 → 부비동 → 상기도 → 하기도 → 순환기 → 소화기 → 전신 [알레르기 비염] 재채기 하나요?/눈, 코가 가렵나요? [부비동염] 코 주위 압통/두통이 있나요?/냄새는 잘 맡나요? [호흡기-상기도] 콧물/코막힘/목 뒤로 코가 흐르는 느낌/목아픔/목 이물감이 있나요? [호흡기-하기도] 흉통/쌩쌩거림/호흡곤란/야간 발한이 있나요? [순환기] 전신 부종/운동 시 호흡곤란/누웠을 때 호흡곤란이 있나요? [소화기 : GERD] 신물/속쓰림/소화불량/복통이 있나요? [전신] 발열/오한/체중 변화/피로가 있나요?
F	특정 계절/찬바람/야간/운동 시에 심해지나요?/최근에 감기에 걸리셨나요? 식후에 더 심해지나요?/누웠을 때 더 심해지나요?/반려동물을 키우시나요? 암기법 추운 밤에 운동하다가 감기에 걸려서, 밥 먹고 누웠어. 설명 추위/밤/운동/감기에 의해 심해지는 지 물어봅니다. + 식후에 심해지는지, 누웠을 때 심해지는지 물어봅니다.
E	이전에 예방접종을 맞은 적 있나요?
외	-
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (알레르기, 천식, 아토피 피부염, 알레르기성 비염) 고혈압이 있으신가요?
약	복용 중인 약물이 있나요? (고혈압약 → ACEi 자세히 물어 볼 것)

사	술은 드시나요?/담배는 피우시나요?/식습관이 어떠신가요? → GERD 감별 직업이 무엇인가요?/근무 환경은 어떤가요?/집안 환경은 어떤가요? (면지)
가	가족 중 알레르기 질환이 있으신 분 계신가요? (천식, 아토피 피부염, 알레르기성 비염) 가족 중 호흡기 질환이 있으신 분 계신가요? (폐렴, COPD, 폐암)
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [아셔야] 1. 눈 : 결막 2. 입 : 구강 발적, 편도 비대, 후비루, 염증 소견 3. 코★ : 발적, 염증 소견, 콧물 → 비경으로 확인 4. 부비동 : 압통 확인 위해 눌러 볼 것 5. 목 : 경부 림프절 촉진 6. 흉부 진찰★ : 흉부 시-촉-타-청 + 심음 청진 7. 사지 : 곤봉지, 청색증
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 동맥혈 채혈 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	기침이 계속 지속되어 많이 불편하고 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 OOO로 미루어 보아 현재 폐렴이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 결핵 등의 호흡기 질환을 완전히 배제할 수는 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 흉부 X-ray, 피검사, 객담배양검사, 폐기능검사 등이 필요할 것 으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 폐렴이 확진된다면 치료를 위해 항생제 치료가 필요할 것입니다. 혹시라도 숨찬 증상이 심해지면 입원 치료가 필요할 수 있으니 말씀해주세요.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있으니 너무 염려하지 마세요.

교육	[기침 기전 설명] 기침은 호흡기도로부터 객담 등의 분비물 또는 이물질을 제거하기 위한 인체의 자연스러운 반사 작용입니다. 그래서 원인이 되는 것을 제거하면 호전될 수 있으므로 너무 염려하지 마세요. [금연 권유] 기침은 담배나 여러 유해 가스로 인해 잘 유발됩니다. 지금 흡연하고 계신데, 금연을 해보시는 것은 어떨까요? [예방접종 권유(천식, COPD)] 평소 천식/만성 폐쇄 폐질환을 가지고 계셔서 감염에 취약한 군에 속하십니다. 독감과 폐렴 쌍구균 예방접종이 필요할 것이라 생각합니다. [환경 관리(알레르기 질환)] 알레르기 질환이 있을 경우 주변 환경을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 집안 청소를 자주 하시고, 이불, 매트리스 커버를 주 1회 섭씨 55℃ 이상 뜨거운 물로 세탁하신 뒤 말려서 사용하시길 바랍니다. 실내 습도는 40~50%로 유지하여 집먼지진드기가 번식하지 않도록 해주세요. [전염성 결핵 환자 관리] 만약 가래의 세균학적 검사에서 결핵균 양성으로 확인되면 타인에게 전염시킬 수 있기 때문에 업무 중사(학생의 경우 등교)의 일시 제한 및 복약 관리가 필요할 수 있습니다. 검사 결과 확인 후에 다시 설명드리겠습니다.
	질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 부비동 방사선 사진, 비경검사
- ② 호흡기 질환 : Chest X-ray, PFT, 메타콜린 유발검사, 객담배양검사. 객담도말검사
- ③ GERD : 위내시경, 24hr 식도 pH 측정

❖ 치료 계획

- ① 대증 치료 : 진해거담제, 항히스타민제, 비충혈제거제
- ② 천식 : β_2 -agonist, 항콜린성제제, theophilline